Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Revisão Flash · Sessão 10

ATLS e Trauma Torácico

O essencial para a prova em uma página

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

ATLS e trauma torácico

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Siga o xABCDE e trate o que mata primeiro: descomprima a tensão sem esperar imagem, drene o hemotórax, sustente a perfusão com sangue até a hemostasia e reavalie a cada passo.

1. **x antes do A:** torniquete na hemorragia externa; ele não trata o sangramento interno.
2. **Falar não é proteger** a via aérea.
3. **Tensão é clínica:** murmúrio abolido + hipotensão = descompressão já.
4. **Onde:** 5º EIC entre as axilares anterior e média, ou 2º EIC na hemiclavicular; 14 G ou mais grosso.
5. Dreno de 14 Fr serve no estável; no instável ou maciço, ≥ 24 Fr.
6. **Toracotomia:** ~1.500 mL ou 200 mL/h por 2–4 h ajudam, mas a fisiologia decide.
7. **TXA** até 3 h: 1 g + 1 g em 8 h, ou 2 g.
8. **Hipotensão permissiva:** sim no penetrante de tronco; não no TCE.

Pneumotórax hipertensivo × hemotórax maciço × tamponamento

	PTX hip.	HTX	Tamp.
Murmúrio	Abolido	Abolido	Normal
Percussão	Timpânica	Maciça	—
Jugular	Túrgida	Colabada	Túrgida

Pegadinha

Piora logo após a intubação? Pense em tensão e em tubo seletivo. Jugular colabada não exclui tensão nem tamponamento (hipovolemia).

Checklist antes da prova

- ☐ Sei a ordem e a pergunta de cada letra do xABCDE
- ☐ Diferencio as três ameaças torácicas
- ☐ Sei onde e como descomprimir
- ☐ Sei os critérios de drenagem e toracotomia
- ☐ Leio a tabela de gravidade da hemorragia
- ☐ Sei interpretar a resposta à ressuscitação
- ☐ Sei dose e janela do TXA